HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (GINECOLOGIA)

JEFE: ELIZABETH CORREA
AUXILIARES : JOHANA GAMBOA
ANYI ROCHA

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General.

Identificar los medicamentos que tienen mayor riesgo de producir daño por manejo inapropiado, identificando los riesgos en todo el proceso de la medicación, que se inicia con la: Selección, almacenamiento, dispensación y administración final al paciente.

1.2. Objetivos Específicos.

- Identificar claramente los medicamentos de alto riesgo.
- Establecer control en el manejo y administración por parte del personal de enfermería e
- Incrementar la seguridad en el uso de estos medicamentos, de acuerdo a lo establecido en el protocolo.

2. ALCANCE DEL PROTOCOLO.

Inicia con la identificación de los riesgos en todo el proceso de la medicación, que se inicia con la: Selección, almacenamiento, dispensación y administración final al paciente.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES	
FARMACEUTICA	La disposición individualizada a que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. es la presentación final de fin producto, definida de su forma farmacéutica y grado de esterilidad
SEGURIDAD	La característica de un medicamento según la cual puede usarse sin mayor posibilidad de causar efectos tóxicos no deseables. La seguridad de un medicamento es una característica relativa
USO ADECUADO DE MEDICAMENTOS	Es un proceso continuo , estructurado y diseñado por el estado, que sera desarrollado e implementado en cada institución y que busca asegurar que los medicamentos sean usados de manera apropiada, segura y efectiva

TERMINOS Y CONDICIONES	
MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO	Son aquellos que cuando no se utilizan correctamente presentan una mayor posibilidad de causar daños altos y graves o incluso mortales (REVISAME)
MEDICAMENTOS LASA O " LOOK - ALIKE, SOUND-ALIKE	(PISI), parecen iguales, suenan iguales ; son aquellos medicamentos generalmente generadores de errores de medicación por su similitud visual, fotogenica u ortografica) (LASA)



Etiqueta

REVISAME

Así se identifica que es un medicamento de alto riesgo



6. CONDICIONES GENERALES DEL PROTOCOLO

ID	Condiciones Generales
1	El Almacenamiento de medicamentos alto riesgo junto con medicamentos comunes, debe estar diferenciado por la etiqueta PARA - REVISAME
2	Antes de dispensar el medicamento debe emplear los pasos de la dispensación segura. Antes de acondicionar el medicamento debe referirse a las siglas PARA (Piensa-Asegúrate-Revisa-Administra)
3	Para evitar confundir nombres parecidos por órdenes verbales, está prohibido dispensar y administrar medicamentos por orden verbal, salvo urgencia (reanimación cardiopulmonar) se deberá parafrasear el medicamento y dosis antes de administrar
4	No se deben aceptar órdenes verbales (Ej. por vía telefónica).
5	Los médicos deben aclarar en las órdenes la vía de administración (Ej: aplicación por vía (IV) medicamentos que solo se puede aplicar vía (IM)).
6	Las órdenes médicas deben tener claro la velocidad de la infusión y se administra medicamentos en goteos muy rápidos desconociendo efectos o no hay control adecuado de bombas o dispositivos de infusión.
7	Verificar las mezclas de medicamentos por omisión y/o el solvente adecuado a usar y por cuánto tiempo se puede conservar.
8	Los medicamentos que requieran cadena de frío deben Transportarse y/o conservarse en recipientes adecuados para su transporte desde de farmacia a los servicios

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Definir el listado de medicamentos de alto riesgo - LASA (comité de farmacia y terapéutica)
- Identificar los medicamentos de ALTO RIESGO Y LASA (Utilizar etiquetas REVISAME Y PARA en carro de medicamentos)
- Leer cuidadosamente las etiquetas de ampollas inyectables antes de preparar confirmar nombre, riesgos, fechas de vencimientos, se deben descartar las que son ilegibles. NO confiar solo en la inspección visual (jefes de enfermería - auxiliares- auxiliares de farmacia- regente quimico farmaceutico)
- Usar nombre genérico de medicamentos a recetar y en caso de presentar confusión como dopamina y dobutamina resaltar con una marca que llame la atención (medico)
- Confirmar con el médico la orden, no acepte ordenes ilegibles o verbales, salvo un caso urgente y repetir la orden escuchada para confirmar si se ha comprendido(jefes de enfermería - auxiliares- auxiliares de farmacia

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Identificar si el paciente es alérgico, tener preparada una orden médica con medicamentos de rescate para una anafilaxia, (Jefes y auxiliares)
- Realizar una doble verificación en la preparación de los medicamentos de ALTO RIESGO, una supervisión controla nuevamente el proceso desde : transcripcion, dilución y administración, (jefes),
- No acepte órdenes sin actualizar como idem o iguales indicaciones (Jefes)
- Nunca dejar medicamentos preparados para administrar después (jefes)
- Verificar el funcionamiento de las bombas de infusión antes de su uso y controlar la velocidad de infusión.

DIEZ CORRECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

1. PACIENTE CORRECTO (NOMBRE COMPLETO, EDAD Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN)
2. MEDICAMENTO CORRECTO
3. DOSIS CORRECTO
4. VIA DE ADMINISTRACION CORRECTA
5. HORA CORRECTA
6. FRECUENCIA CORRECTA
7,. RECONSTRUCCION Y DILUCION CORRECTA
8. EDUCACIÓN AL PACIENTE
9. VELOCIDAD DE ADMINISTRACIÓN CORRECTA
10. REGISTRO CORRECTO





MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

En el servicio de ginecología, los **medicamentos de alto riesgo** son aquellos que tienen una mayor probabilidad de causar daño grave al paciente si se usan de forma incorrecta. Su manejo requiere protocolos estrictos, doble verificación y vigilancia constante.

1. Oxitócicos

- Oxitocina
- Misoprostol

  Riesgos: hiperestimulación uterina, ruptura uterina, sufrimiento fetal

  Uso: inducción del trabajo de parto, control de hemorragias

2. Anticoagulantes

- Enoxaparina

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

- **Riesgos:** hemorragias severas
  Uso: prevención y tratamiento de trombosis

3. Magnesio intravenoso

- Sulfato de magnesio
  Riesgos: depresión respiratoria, paro cardíaco
  Uso: preeclampsia y eclampsia

4. Insulina

- Insulina
  Riesgos: hipoglucemia grave
  Uso: diabetes gestacional o preexistente

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

5. Labetalol

Es un **antihipertensivo** que actúa bloqueando receptores **alfa y beta**, lo que produce:

- Disminución de la presión arterial
- Reducción de la frecuencia cardíaca

- Uso en ginecología y obstetricia

- **Preeclampsia**
- **Eclampsia**
- **Crisis hipertensiva en el embarazo**

Es uno de los fármacos de elección porque es **seguro y efectivo en gestantes** bajo supervisión médica.

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

⚠️ ¿Por qué es de alto riesgo?

- Puede causar **hipotensión severa** (bajada brusca de la presión)
- Produce **bradicardia** (latidos lentos)
- Puede afectar la **frecuencia cardíaca fetal**
- Requiere **dosificación precisa y monitoreo continuo**

Efectos adversos importantes

- Mareo o desmayo
- Fatiga
- Náuseas
- Disminución excesiva de la presión arterial

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

- La **Inmunoglobulina anti-D** (también llamada **anti-Rh(D)**) es un medicamento clave en ginecología y obstetricia para prevenir complicaciones graves en el embarazo.

¿Qué es? Es un preparado de **anticuerpos** que se administra a mujeres con **factor Rh negativo** para evitar que desarrollen anticuerpos contra la sangre Rh positiva del feto.

¿Para qué se usa? Se indica en:

- Embarazadas **Rh negativo** con feto potencialmente Rh positivo
- Después del parto si el bebé es Rh positivo
- Abortos, embarazos ectópicos o procedimientos invasivos (amniocentesis)
- Sangrados durante el embarazo

¿Por qué es importante?

Previene la **Enfermedad hemolítica del recién nacido**, una condición que puede causar:

- Anemia fetal severa
- Ictericia grave
- Daño cerebral o incluso muerte fetal

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

¿Es de alto riesgo?

No suele clasificarse como “medicamento de alto riesgo” como otros (ej. oxitocina o magnesio), pero **requiere manejo estricto** porque:

- Debe administrarse **sólo a pacientes correctamente tipificadas (Rh negativo)**
- Un error en la indicación o paciente puede hacerlo innecesario o ineficaz

Dato clave

- Se administra de forma rutinaria alrededor de la **semana 28 de gestación**

  y dentro de las **72 horas postparto** si el bebé es Rh positivo.

IMPORTANTE ….



- Control estricto de **signos vitales**
- Monitorización materno-fetal
- Administrar lentamente (especialmente IV)
- Verificación doble antes de administrar

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ANA MARITZA DÁVILA BARÓN

GERENTE